

Psykiatri forår 2026

Behandlingsprincipper

Ida Hageman

Enhver behandling er en afvejning af
effekt over for bivirkninger



Psykiatrisk behandling

- Medikamentel behandling
- ECT (Electro Convulsive Therapy)
- Fysioterapeutisk behandling
- Samtaleterapi
- (Socialpsykiatrisk støtte – ikke egentlig behandling men et vigtigt fundament for behandling)

Typer af psykofarmaka

- Antipsykotika
- Antidepressiva
- Stemningsstabiliserende medicamina
- Anxiolytika/hypnotika
- Farmaka til behandling af misbrug
- Bivirkningsmedicin

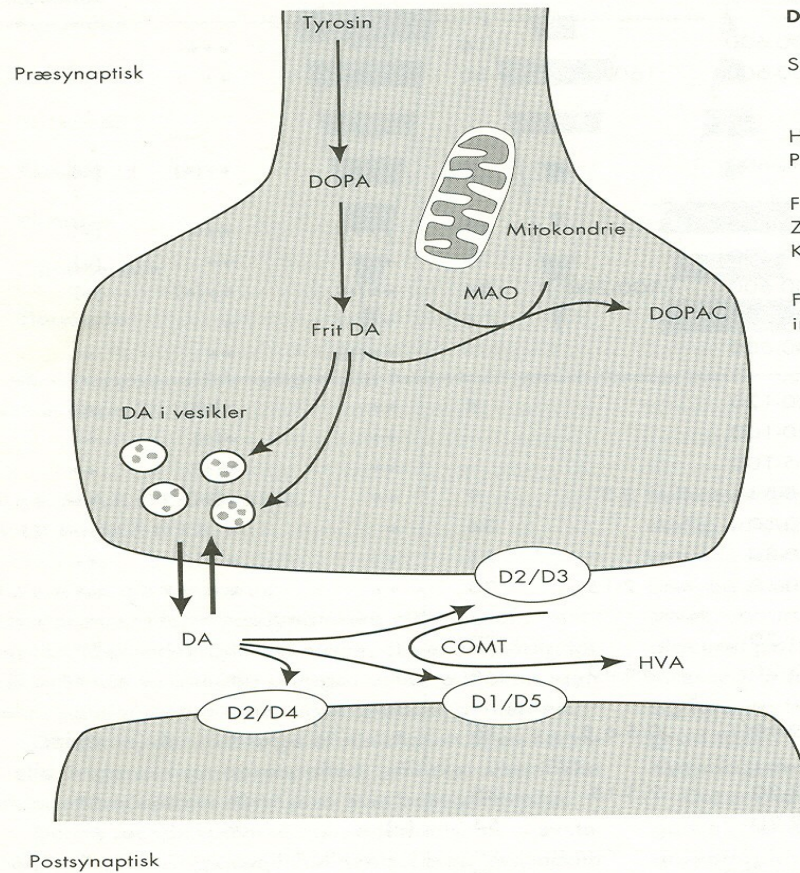
Behandling af psykoser

- Typiske antipsykotika
- Atypiske antipsykotika
Typiske og atypiske antipsykotika adskiller sig bl.a. ved bivirkningsprofil
- Støttende og psykoedukative samtaler. Kognitiv terapi kan endvidere til en vis grad anvendes hos en del.

Synapse



DEN DOPAMINERGE SYNAPSE



Dopaminantagonister

SULPIRID Selektiv D2
receptor blokade

HALOPERIDOL Overvejende D2
PERFENAZIN receptor blokade

FLUPENTIXOL Blandet D1/D2
ZUKLOPENTIXOL receptor blokade
KLOZAPIN

Flere receptorer kan blokeres
indenfor samme familie

D1, 2, ... : dopaminreceptorer

DA: dopamin

D1 receptorsubfamilier: D1 og D5

D2 receptorsubfamilier: D2, D3 og D4

DOPA: dihydroxyfenylalanin

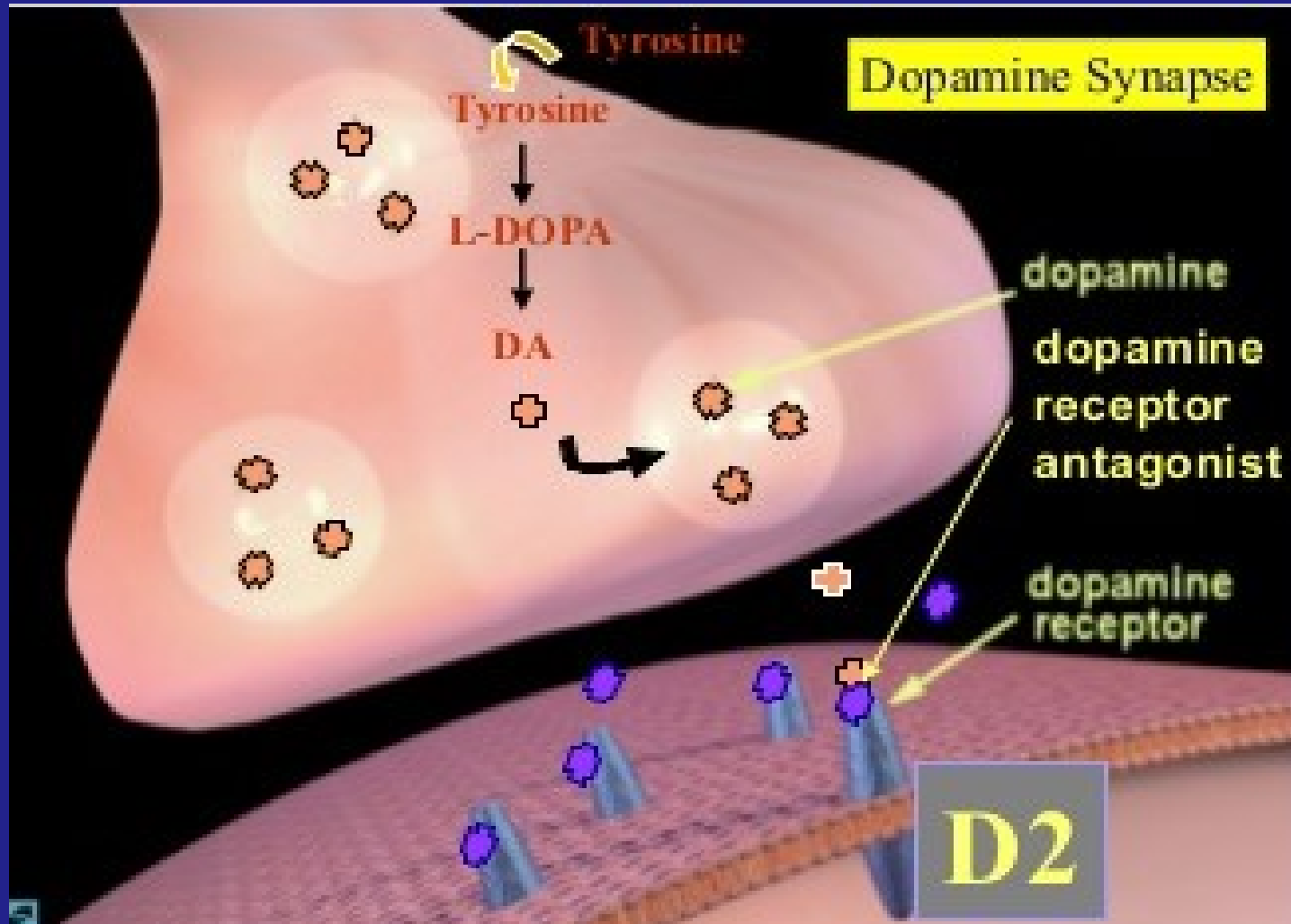
DOPAC: dihydroxyfenyleddikesyre

COMT: catechol-O-methyltransferase

HVA: homovanillinsyre

MAO: monoaminoxidase

Antipsykotisk medicin blokerer dopaminreceptor



Bivirkninger - antipsykotika

- Parkinsonisme
- Akatisi
- Autonome bivirkninger
- Vægtøgning
- Sedation
- Akut dystoni
- Tardive dyskinesier

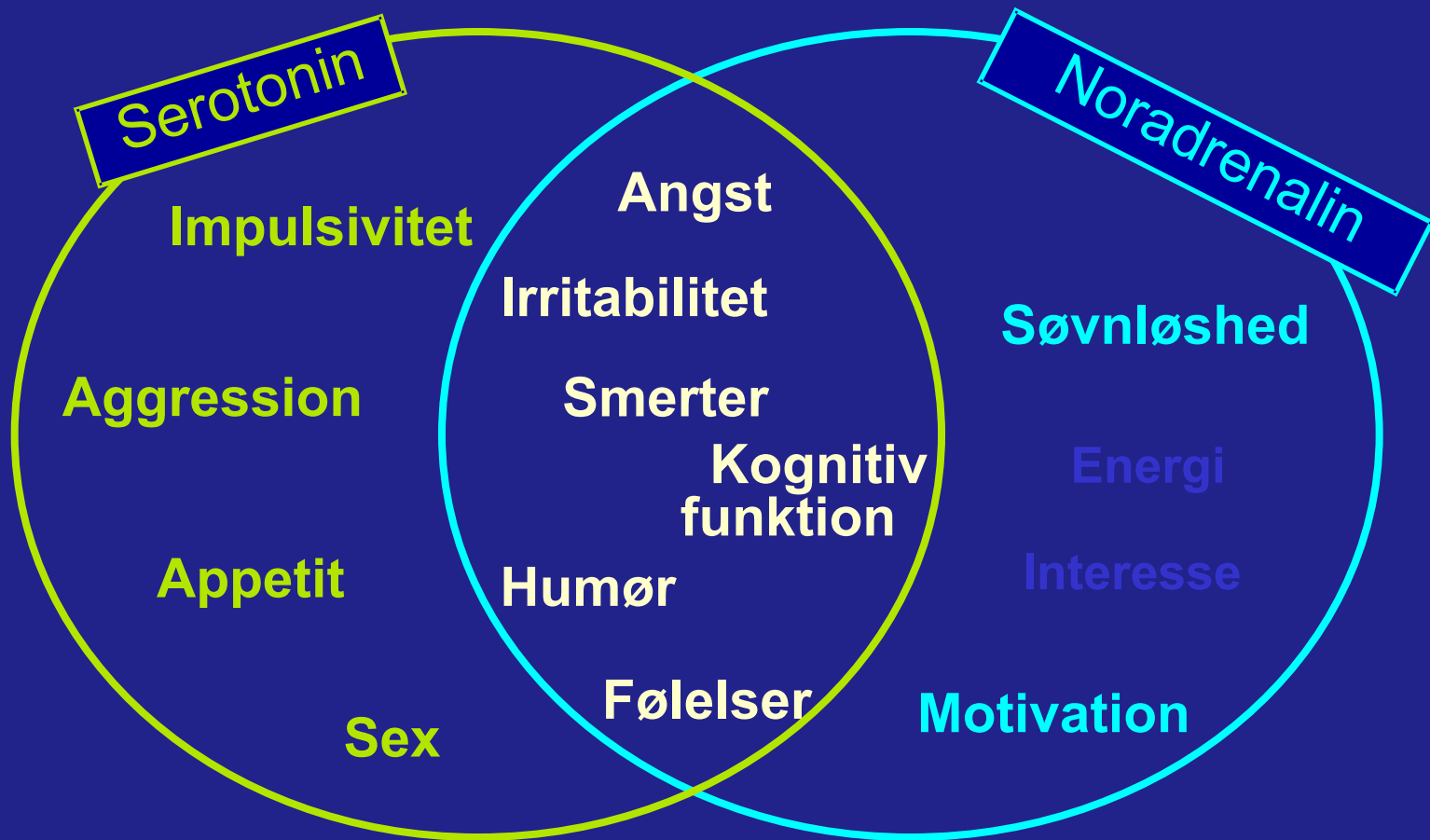
Behandling af depressioner

Antidepressiva

- Tricykliske antidepressiva (TCA)
- Selektive serotonin reuptake inhibitorer (SSRI)
- Serotonin noradrenalin reuptake inhibitorer (SNRI)
- Monoaminoxidase inhibitorer (MAOI)
- Psykoterapi

Det umiddelbare nettoresultat ved behandling med antidepressiva er et øget udbud af aminer i den synaptiske spalte. Herefter sker en lang række biologiske (biokemiske og anatomiske/strukturelle) ændringer, der har til formål at genoprette ”homeostase”.

Funktionelle domæner for serotonin og noradrenalin¹⁻⁵

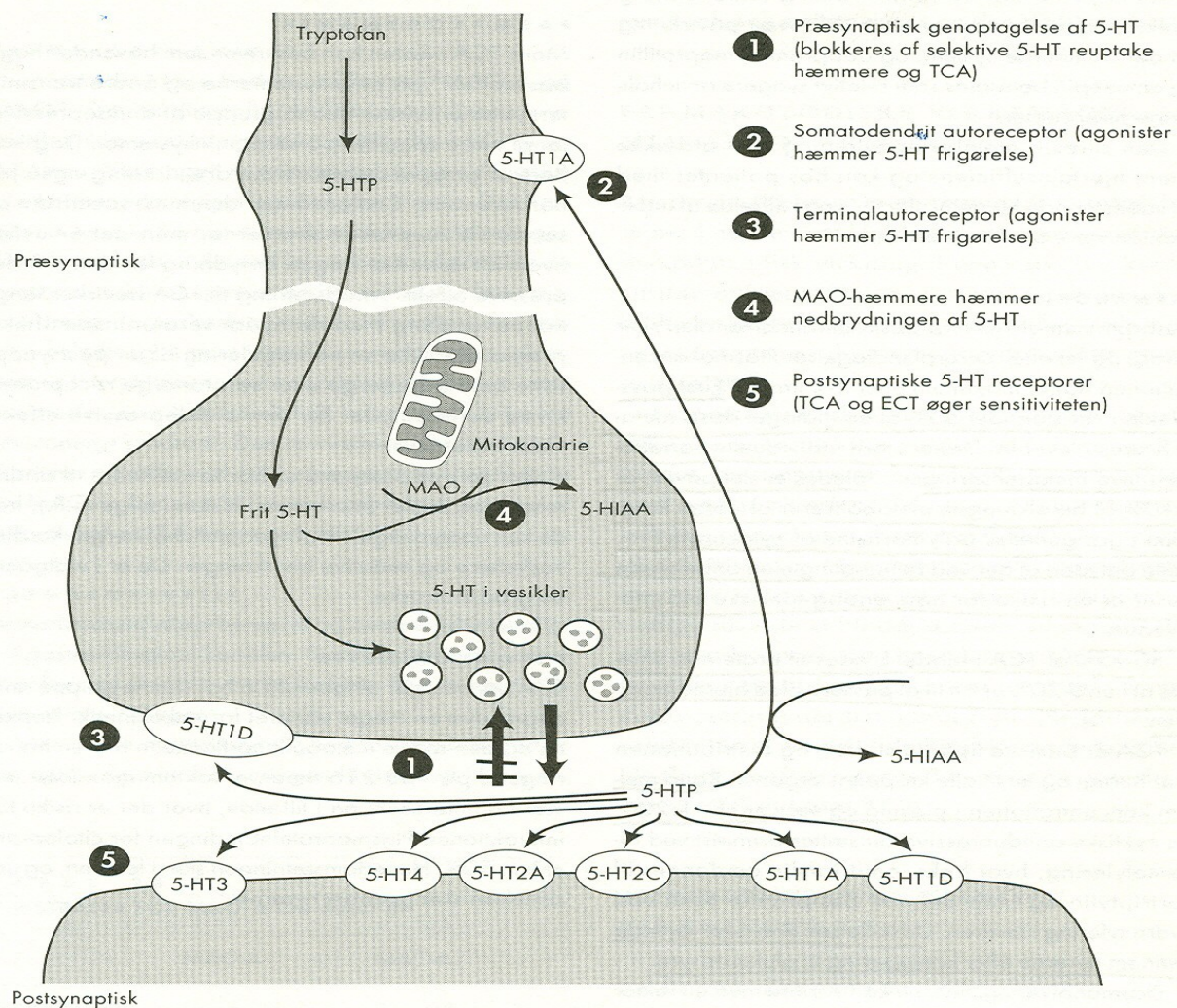


1. Tilpasset fra: Stahl SM. *Essential Psychopharmacology of Depression and Bipolar Disorder*. Cambridge University Press, United Kingdom. 2000: 65-109.
2. Verma, S, et al. *Int Rev Psychiatry*. 2000;12:103-114.

3. Blier P, et al. *J Psychiatry Neurosci*. 2001;26:37-43.
4. Doraiswamy PM, *J Clin Psychiatry*. 2001;62(suppl12):30-35.
5. Frazer A, *J Clin Psychiatry*. 2001;62(suppl12):16-23.

- Tricykliske antidepressiva virker ved at blokere den præsynaptiske genoptagelse af aminer
- Monoaminoxidase hæmmere virker ved at blokere den præsynaptiske nedbrydning af aminer.

DEN SEROTONERGE SYNAPSE



5-HTP: 5-hydroxytryptofan
5-HT: serotonin

5-HIAA: 5-hydroxyindoleddikesyre
5-HT 1, 2, . . . : receptorer

MAO: monoaminoxidase
TCA: tricykliske antidepressiva
ECT: elektrokonvulsiv terapi

Bivirkninger – antidepressiva

Tricykliske

- Vægtøgning
- Mundtørhed, forstoppelse, synsgener
- Sedation
- EKG-forandringer
- Seksuelle bivirkninger

Bivirkninger – antidepressiva

SSRI

- Gastrointestinale
- Søvnforstyrrelser
- Hovedpine
- Svedtendens
- Seksuelle bivirkninger

Forebyggelse bipolar affektiv sygdom samt behandling af mani

- Lithium
- Anticonvulsiva (antiepileptica)
- Atypiske antipsykotika
- Psykoterapi /psykoedukation

ECT = Electro Convulsive Therapy

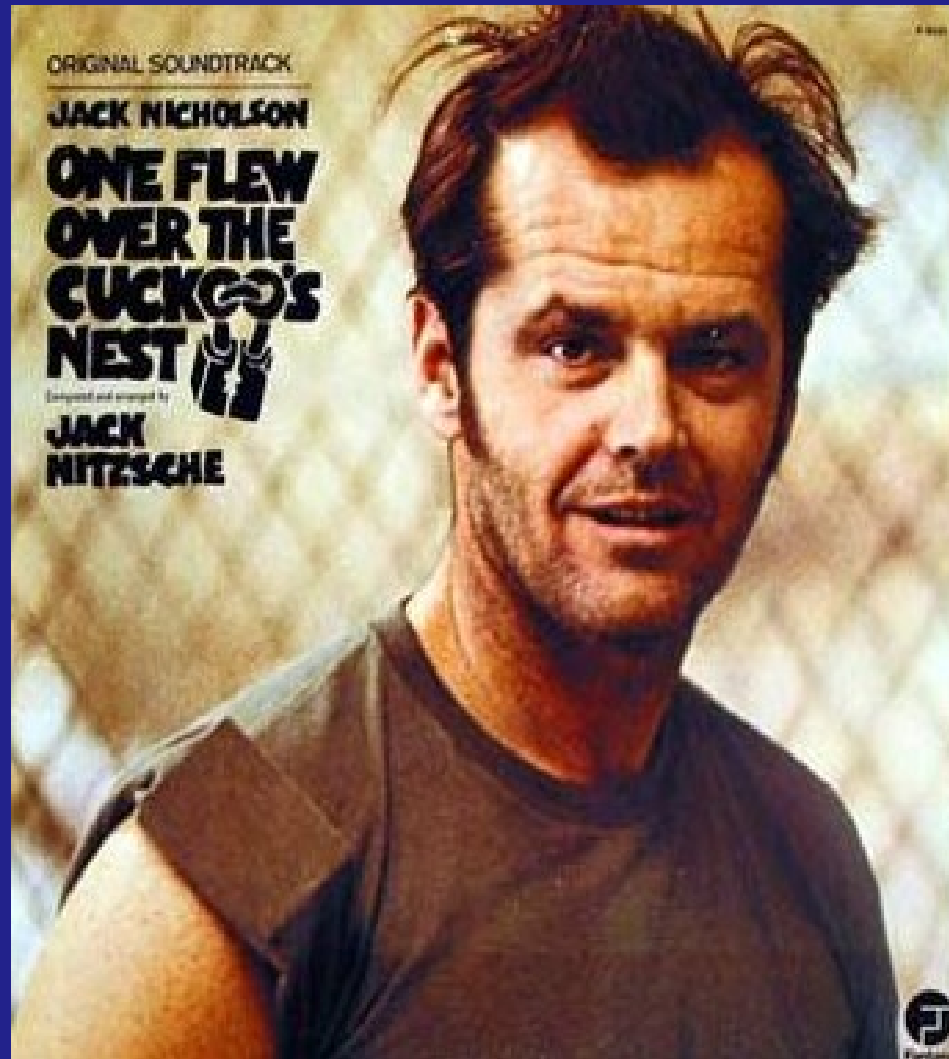


Paracelsus (1493-1541)

- Von Meduna, Ungarn 1929:
sammenhæng mellem
epilepsi og skizofreni? ("I
accepted the concept of a
biological antagonism
between the two diseases")
- Von Meduna 1934:
Kamferinjektion til patient
med skizofreni.
- Cerletti & Bini 1938 i Rom:
Elektrisk inducerede kramper
introduceres, ligeledes til
patient m skizofreni.



Flere forhold har været med til at dæmonisere behandlingen, men bl.a. film hvor forkert (ikke klinisk) brug af ECT afbildes.



Fantastisk film, der dog ikke afspejler korrekt brug af ECT 22



FORDOMMENE



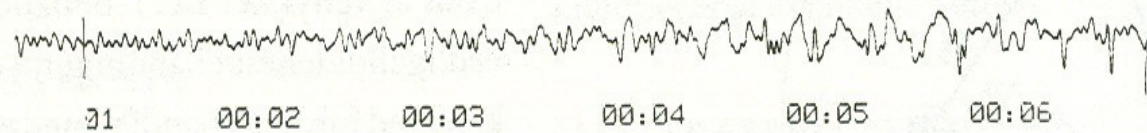
Film om Francis Farmer

- **Postmortem studier af ECT hjerner ikke forskellige fra normale hjerner**
- **Neuropsykologiske langtidsstudier har ikke fundet kognitive deficits.**

Depression kan give hjerneskade

TYPISK EEG VED UNILATERAL ECT

TIDLIGE DEL



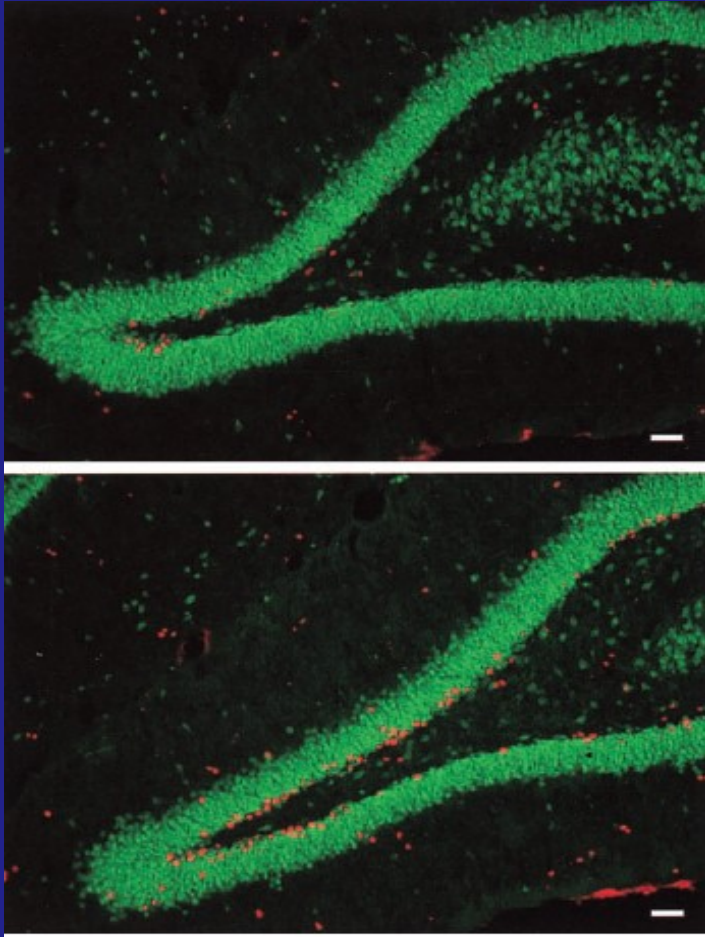
MIDTERSTE DEL



SENE DEL



Neurogenese i hippocampus

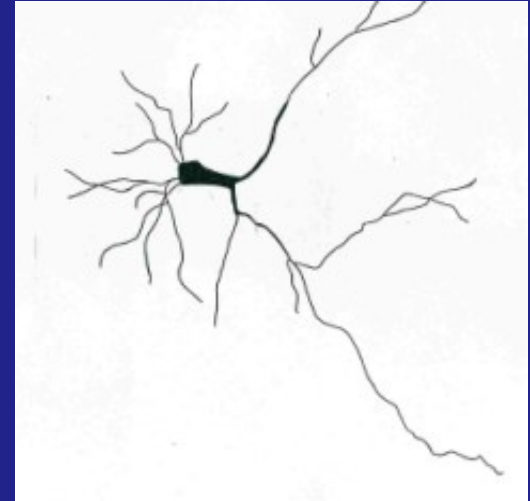
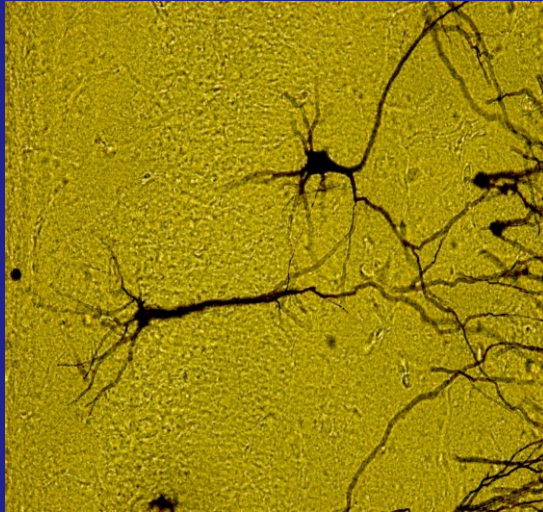


Kontrol
hjerne

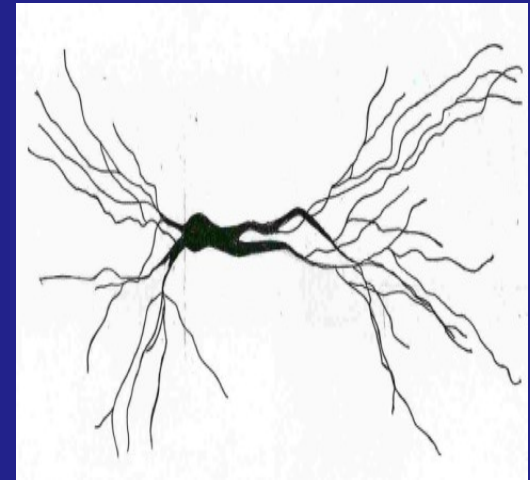
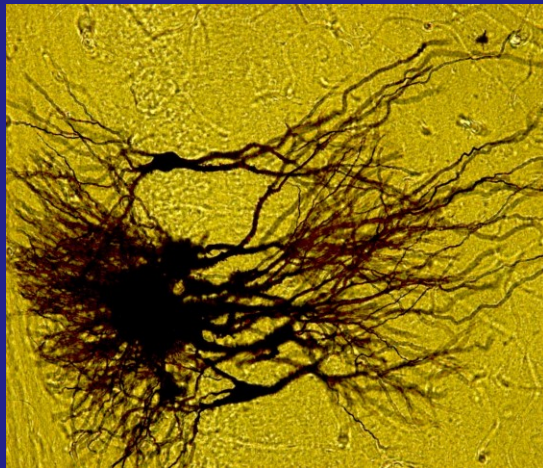
ECT
hjerne

Madsen et al, Biol Psychiatry, 2000

Stress



**Stress +
ECS**



Indikationerne for ECT

**Svær depressiv tilstand – især med
melankoliforme og psykotiske
symptomer**

Svær manisk tilstand

**Svær medicinsk behandlingsrefraktær
psykose (herunder skizofreni)**

Delirøs tilstand

Fysioterapeutisk behandling

herunder bla

- Træning af kropsbevidsthed
- Angstdæmpende øvelser
- Motion - coaching

Psykoterapi

- Kognitiv terapi
- Adfærdsterapi
- Støttende terapi
- Interpersonel terapi